Лечение алкогольной зависимости: почему сила воли здесь ни при чём

05.05.2026 • 5 минут на чтение

Автор: Шпиговский С.Ю.

Оглавление:

- Алкоголизм как болезнь мозга: эндогенная природа зависимости
- Кто на самом деле пьет: развенчивая стереотип о "неудачниках"
- Психологические механизмы зависимости: что происходит внутри
- Нейробиология встречает психологию: как это работает вместе
- Стационарное лечение алкогольной зависимости: что важно знать

> Есть расхожее мнение, что алкоголизм — это история про слабохарактерных людей, которые просто не хотят взять себя в руки. Оно настолько въелось в культуру, что даже сами зависимые в него верят и это, пожалуй, один из самых разрушительных мифов, с которым приходится работать нашим специалистам (должна быть ссылка на стр о спецах) по лечению зависимостей. Потому что пока человек убежден, что его проблема называется "слабая воля", он будет бороться не с тем, с чем нужно.
>
> Давайте разберёмся, что на самом деле происходит в голове у зависимого человека, кто им становится и почему современное лечение алкогольной зависимости (должна быть ссылка на стр лечения) это не про кодирование и не про "завязать раз и навсегда".

Алкоголизм как болезнь мозга: эндогенная природа зависимости

Дофаминовая система и синдром дефицита вознаграждения

В основе практически любой химической зависимости, включая алкогольную, лежит нарушение работы мезолимбической дофаминовой системы. Той самой нейронной сети, которая отвечает за переживание удовольствия, мотивацию и подкрепление поведения.
Центральная идея современной аддиктологии — концепция Синдрома Дефицита Вознаграждения (от англ. Reward Deficiency Syndrome (RDS)). Суть её в следующем: у части людей изначально снижена активность системы вознаграждения мозга, а именно гипофункция мезолимбической дофаминовой системы. Особенно страдают:

- вентральная область покрышки (расположена в среднем мозге) — важнейший центр системы вознаграждения, который генерирует дофаминовый сигнал;
- nucleus accumbens (лат. прилежащее ядро) — главный центр обработки удовольствия, принимающий этот сигнал;
- префронтальная кора головного мозга — управляющий центр, ответственный за контроль импульсов и принятие решений.

Проще говоря, у человека с СДВ (Синдром Дефицита Вознаграждения) мозг хронически недополучает "зёрнышко" дофамина в ответ на обычные жизненные события. То, что у другого человека вызовет нормальное удовольствие — вкусная еда, общение, достижение цели — у него едва регистрируется. Это не лень и не капризы, а нейробиология.

Алкоголь в этой ситуации делает ровно одно: он искусственно и грубо форсирует выброс дофамина. Мозг получает то, чего ему хронически не хватало, и запоминает это. Формируется устойчивая нейронная ассоциация: алкоголь = облегчение = решение проблемы. С точки зрения мозга, увы, это совершенно рациональное поведение.

Генетика: кому достался этот "жребий"

Исследования в области поведенческой генетики устойчиво показывают, что наследуемость алкогольной зависимости составляет от 50 до 60%. Это означает, что примерно половина риска развития алкоголизма определяется генетически ещё до того, как человек выпил первый стакан.

Генотипирование — анализ полиморфизмов генов, регулирующих нейромедиаторные системы, позволяет выявить индивидуальные факторы риска. Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) даёт возможность определить особенности рецепторов к дофамину, серотонину и эндогенным опиатам, а также специфику белков обратного захвата нейромедиаторов. Именно эти показатели конкретизируют черты синдрома дефицита удовлетворенности у конкретного человека.

Поэтому мы включаем генотипирование (должна быть ссылка на стр об анализе) в процесс лечения и профилактики зависимости. Оно нужно не для того, чтобы снять с человека ответственность, а для того, чтобы точнее понять, с чем именно мы имеем дело. Вы не можете "захотеть" иметь другие рецепторы дофамина, так же, как нельзя "захотеть" иметь другой рост.

Кто на самом деле пьет: развенчивая стереотип о "неудачниках"

Статистика, которая неудобна

Принято думать, что алкоголизм — это удел социального дна. Бездомные, безработные, люди без образования и перспектив. Эта картинка удобна, так как она позволяет думать "это не про меня" и откладывать обращение за помощью до тех пор, пока проблема не разрастётся до катастрофических масштабов.

Реальность другая. По данным ВОЗ, Минздрава и крупных эпидемиологических исследований:

- среди людей с высшим образованием и высоким доходом распространённость проблемного употребления алкоголя сопоставима с общепопуляционными показателями, а в ряде исследований выше;
- руководители высшего звена, врачи, юристы, предприниматели входят в группы профессионального риска из-за высокого хронического стресса и культуры "рабочих" застолий;
- по данным Минздрава России около 900 000 граждан официально состоят на учете с диагнозом “алкоголизм” и “алкогольный психоз”. Казалось бы, это крохи среди всего взрослого населения нашей страны, но это только официальный диагноз. А общая статистика алкоголизма в России обнажает куда более масштабную цифру: около 30% трудоспособного населения злоупотребляет алкоголем.

Алкоголизм не выбирает по социальному статусу. Он выбирает по нейробиологии и, в меньшей степени, по обстоятельствам жизни, которые эту нейробиологию активируют.

Успешный, умный, зависимый

Среди людей с высокими достижениями алкогольная зависимость нередко маскируется особенно долго. Механизм понятен: высокий интеллект, в частности, выступает мощным аппаратом для рационализации. Человек легко и с удовольствием может объяснить себе и другим, почему он пьет "не как алкоголик", почему "держит себя в руках", почему "это стресс, а не болезнь".

Кроме того, работающий человек с ресурсами долго может компенсировать последствия употребления деньгами, связями, способностью восстанавливаться. До того момента, пока эти компенсаторные возможности не исчерпываются.

Это не означает, что успешный человек "виноват" больше других. Это означает, что промежуток между началом проблемы и обращением за помощью у него, как правило, дольше и потери за это время больше.

Психологические механизмы зависимости: что происходит внутри

Зависимость как решение, а не как проблема

Один из самых продуктивных сдвигов в понимании зависимостей — это взгляд на алкоголизм не как на проблему, а как на решение. Решение, которое перестало работать, но мозг об этом ещё не знает.

Алкоголь “решает” целый спектр психологических задач:

- снижает тревогу (анксиолитический эффект, то есть подавление тревожности),
- облегчает социальное взаимодействие,
- гасит навязчивые мысли,
- даёт ощущение расслабления и внутренней опоры.

Для человека, у которого нет других эффективных инструментов регуляции эмоционального состояния, это не слабость, а единственный найденный способ справляться.

Поэтому лечение зависимости, которое ограничивается требованием "не пить", обречено на провал. Это всё равно что забрать у человека единственный инструмент и не дать другого. Где-то под зависимостью всегда есть дефицит:

- навыков регуляции,
- опыта безопасных отношений,
- способности переносить дискомфорт,
- внутренней устойчивости.

Психологические факторы риска

Аддиктология выделяет некоторые устойчивые психологические характеристики, которые повышают уязвимость к зависимости:

Эмоциональная дисрегуляция — сниженная способность управлять эмоциональными состояниями, особенно отрицательными. Человек, который не умеет переносить тревогу, тоску или злость иначе как "выключив" их, рано или поздно найдёт химический способ это сделать.

Алекситимия (от греч. alexithymia "без слов для чувств") — затруднённость в распознавании и описании собственных эмоций. Такие люди буквально не понимают, что именно они чувствуют и единственное, что они считывают — интенсивность внутреннего дискомфорта. Алкоголь снижает интенсивность и это воспринимается как решение.

Высокий уровень хронического стресса в сочетании с дефицитом копинговых стратегий (от англ. coping strategies стратегии совладания со стрессом). Человек знает только один способ справиться и это тот, который работает быстро.

Нарушения привязанности — если в раннем опыте не было безопасных, стабильных отношений, человек не формирует внутреннего ощущения опоры. Алкоголь становится суррогатом этой опоры.

Нейробиология встречает психологию: как это работает вместе

Почему психологической работы недостаточно без учёта нейробиологии

Долгое время психотерапия зависимостей строилась преимущественно на работе с убеждениями, мотивацией и поведением. Это важно, но недостаточно. Человек может полностью осознать природу своей зависимости, иметь высокую мотивацию к изменениям и всё равно срываться. Не потому что "не хочет бросить", а потому что нейронные паттерны, сформированные годами употребления, продолжают работать.

Хроническое злоупотребление алкоголем вызывает структурные изменения в мозге: снижается объём серого вещества в префронтальной коре, нарушается функция гиппокампа (область мозга, критичная для формирования новых воспоминаний и пространственной навигации), изменяется баланс возбуждающих и тормозящих нейромедиаторных систем. Всё это влияет на способность принимать решения, контролировать импульсы и формировать новые поведенческие паттерны.

Поэтому современный подход к лечению зависимости совмещает нейробиологический и психологический уровни работы.

Нейропсихологическая коррекция как часть лечения

Нейропсихологическая коррекция — немедикаментозный метод, основанный на тренировке определённых зон мозга через специально разработанные задания и упражнения. В работе с зависимостями она применяется для восстановления исполнительных функций (планирование, рабочая память, когнитивный контроль), снижения импульсивности и повышения стрессоустойчивости.

Отдельного внимания заслуживает БОС-терапия (Биологическая обратная связь). Метод позволяет человеку в режиме реального времени наблюдать показатели собственной нервной системы и учиться их регулировать. Мозг получает обратную связь о своей активности и постепенно формирует более адаптивные паттерны. По сути, это обучение мозга — прямое, без посредников.

Нейродиагностика в начале и конце программы позволяет объективно отследить динамику: как изменился эмоциональный статус, уровень активности, способность ориентироваться в стрессовых ситуациях.

Психокоррекционные программы: что должно быть внутри

Эффективная психологическая программа при лечении алкогольной зависимости строится на результатах психодиагностики (серии интервью, стандартизированных опросников и клинических наблюдений), которые позволяют определить индивидуальный профиль рисков.

Хорошая программа работает одновременно в нескольких направлениях:

- формирует внутреннюю опору и навыки саморегуляции;
- развивает способность распознавать и управлять эмоциями;
- создаёт новые формы поведения в социальных ситуациях;
- исследует причины зависимости, а не только её симптомы.

Кроме индивидуальной работы, групповой формат имеет самостоятельную ценность, ведь именно в группе формируется опыт безопасных отношений, который у многих зависимых отсутствовал.

Стационарное лечение алкогольной зависимости: что важно знать

Когда стационар необходим

Амбулаторное лечение возможно и эффективно при лёгкой степени зависимости, при активно сохранной социальной среде и высокой мотивации. Однако есть ситуации, когда стационарный формат не опция, а необходимость:

Ситуация 1. Тяжёлая физическая зависимость с синдромом отмены. Резкий отказ от алкоголя при сформированной физической зависимости может вызвать жизнеугрожающие состояния, например, алкогольный делирий, судорожные приступы. В таких случаях медицинский контроль в этот период критически важен.

Ситуация 2. Токсичная среда в которой окружение человека поддерживает употребление. Нередко желающий избавиться от алкогольной зависимости имеет дома алкоголь, что совсем не способствует выздоровлению. И вытащить человека из этой среды физически в стационарные условия центра лечения и профилактики, иногда становится единственным способом дать ему возможность начать работу.

Ситуация 3. Неоднократные срывы при амбулаторных попытках. Если “с понедельника точно всё” не сработало как минимум дважды, то это сигнал, что интенсивность воздействия и возможностей справиться самостоятельно недостаточны.

Ситуация 4. Коморбидные психические расстройства, то есть сочетание алкогольной зависимости с депрессией, тревожным расстройством, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и др. требует более комплексного и интенсивного подхода.

На что обращать внимание при выборе стационарной программы

Хороший реабилитационный центр отличается не тем, что он обещает "вылечить навсегда" или "гарантирует результат" — такие формулировки сами по себе красный флаг. Стоит обращать внимание на следующее.

Индивидуализация программы. Если вам предлагают стандартный пакет без предварительной диагностики это плохой знак. Нормальная программа начинается с изучения конкретного человека:

- его нейропсихологического профиля,
- психологических особенностей,
- истории зависимости,
- сопутствующих проблем.

Сочетание работы с телом, психикой и нейробиологией. Зависимость, как мы уже рассказали, системная проблема. Только "разговорная" терапия или только физические нагрузки недостаточные усилия. Сильная программа (должна быть ссылка на стр. программы) включает и физическую активность, и психологическую работу, и нейрокоррекцию, и работу с социальными навыками.

Атмосфера и среда. Жесткий режим, стрессовая среда, ощущение изоляции максимально контрпродуктивно. Человек учится саморегуляции и новым паттернам поведения в безопасной, принимающей обстановке. Не в условиях дополнительного давления.

Немедицинский и медицинский ресурс в одном месте. Социально-психологическая реабилитация и медицинская помощь (при необходимости) должны быть доступны. Хороший центр работает с врачами, но не является психиатрическим стационаром, так как это разные вещи с разными задачами.

Возможность гостевого визита. Нормальный центр не скрывает, как он работает. Возможность приехать, посмотреть, поговорить с сотрудниками до того, как принято решение должно быть признаком открытости и уверенности в качестве своей работы.

Чего ожидать от процесса

Реабилитация — это не просто курс лечения с четким началом и концом, после которого "всё будет хорошо". Это процесс формирования нового образа жизни, новых нейронных паттернов и новых навыков. Стационарный этап — интенсивный, важный, но только первый шаг.

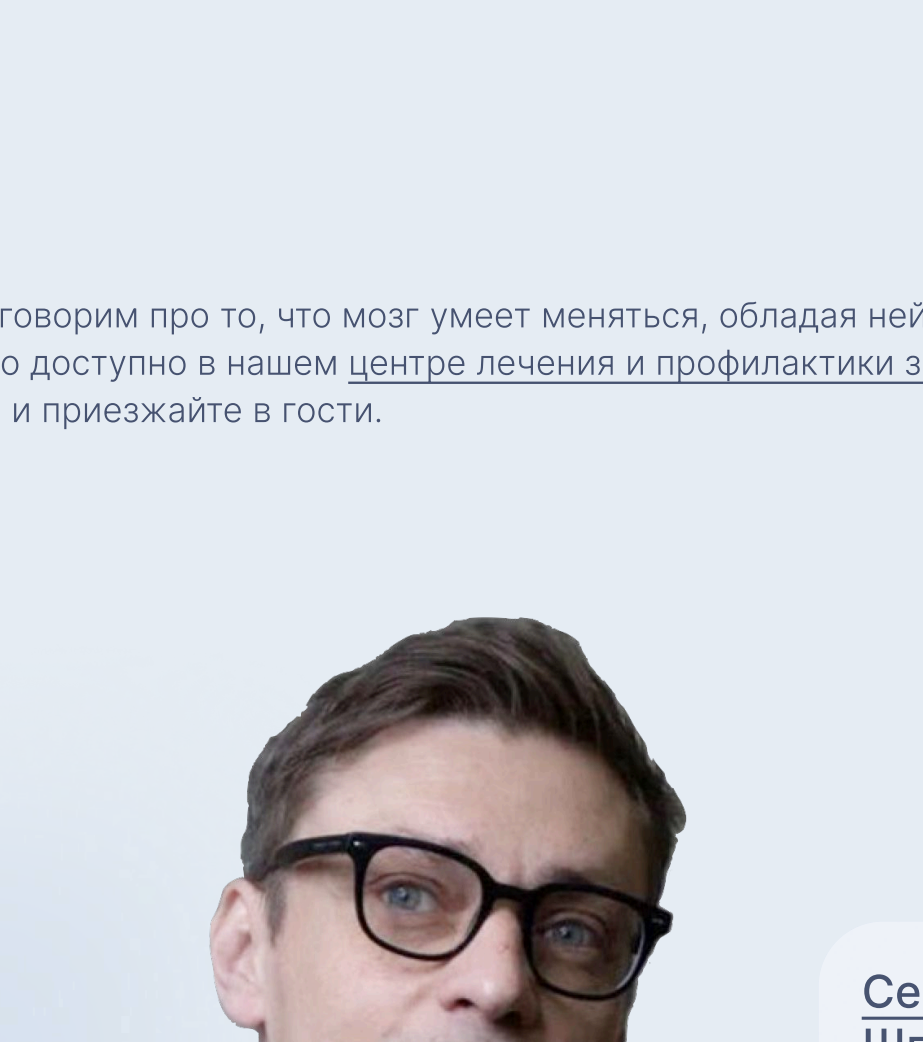
Хорошим прогнозом для избавляющего от алкогольной зависимости будет, если у такого человека после реабилитации появляются внутренние инструменты, которых у него не было до:

- способность распознавать триггеры,
- навыки регуляции эмоций,
- понимание своей нейробиологии,
- поддерживающая среда,
- продолжение работы с психологом.

Поэтому не погружайтесь в терзания про "силу воли". Это другое. Мы говорим про то, что мозг умеет меняться, обладая нейропластичностью и что для этого нужна правильная среда и правильные инструменты. Все это доступно в нашем центре лечения и профилактики зависимостей (тут должна быть ссылка на гл.страницу). Записывайтесь на консультацию и приезжайте в гости.

Заключение

> Алкоголизм — это не моральный провал и не слабость характера. Это сложное биопсихосоциальное расстройство с понятной нейробиологической базой, психологическими механизмами и доказанными методами лечения. И первый шаг к выходу из него это перестать объяснять его себе как проблему воли. Потому что пока человек борется с собственной слабостью, болезнь продолжает делать своё дело.



Сергей Юрьевич Шпиговский
Основатель центра.
Аддиктолог,
интервенционист

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Источники:

Менделевич В.Д. (ред.) (2007). Руководство по аддиктологии. СПб.: Речь, 768 с.

Blum K., Sheridan P.J., Wood R.C., Braverman E.R., Chen T.J., Comings D.E. (1996). The D2 Dopamine Receptor Gene as a Determinant of Reward Deficiency Syndrome. Journal of the Royal Society of Medicine, 89(7), 396–400. doi:10.1177/014107689608900711

Гриневич В.П., Немец В.В., Крупицкий Е.М., Гайнетдинов Р.Р., Будыгин Е.А. (2022). Роль дофамина и норадреналина в алкоголь-зависимом поведении: от корреляций к механизмам. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева, 56(3), 13–29. doi:10.31363/2313-7053-2022-56-3-13-29

Анохина И.П. (2013). Основные биологические механизмы зависимости от психоактивных веществ. Вопросы наркологии, № 6, 40–59.

Анохина И.П. (1988). Нейробиологические аспекты алкоголизма. Вестник РАМН, № 3, 21–30.

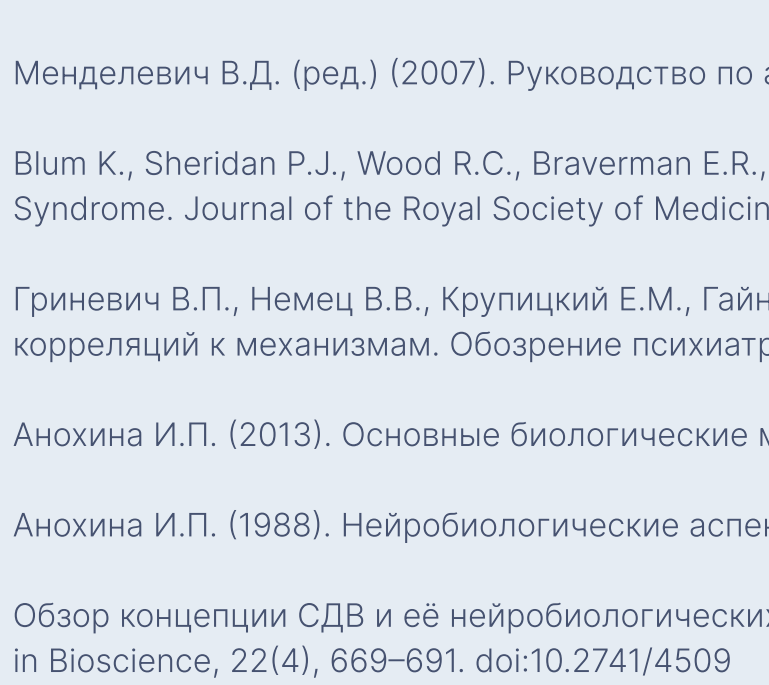
Обзор концепции СДВ и её нейробиологических оснований: Dopamine homeostasis: brain functional connectivity in reward deficiency syndrome (2017). Frontiers in Bioscience, 22(4), 669–691. doi:10.2741/4509

Verhulst B., Neale M.C., Kendler K.S. (2015). The heritability of alcohol use disorders: a meta-analysis of twin and adoption studies. Psychological Medicine, 45(5). PMC4345133

Николишин А.Е., Бродянский В.М., Чупрова Н.А., Кибитов А.О. Генетические особенности дофаминергической нейромедиаторной системы у пациентов с сочетанием алкогольной зависимости и депрессии. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. doi:10.31363/2313-7053-2019-4-1-124-126

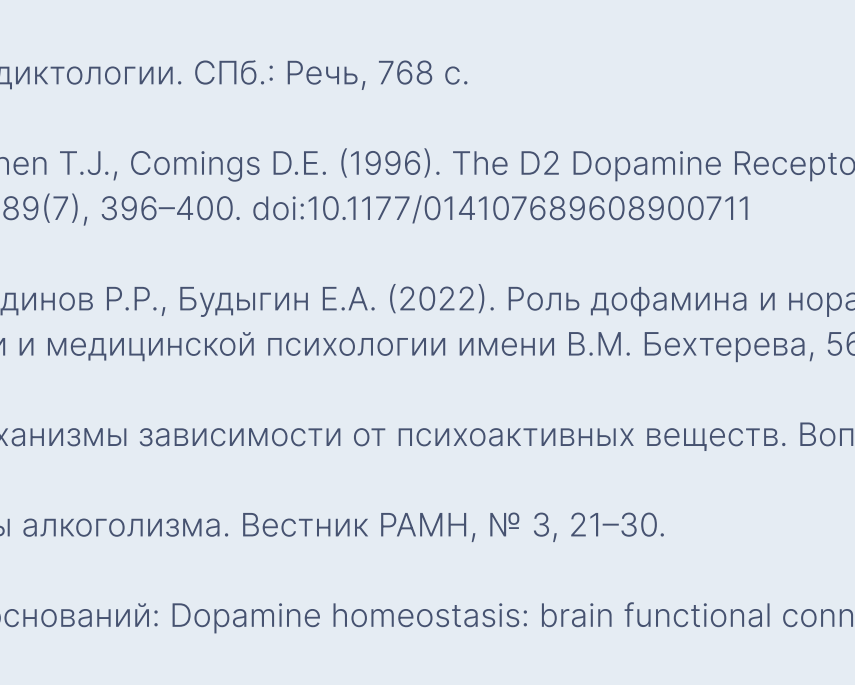
Рекомендуем к прочтению

ВСЕ СТАТЬИ ►



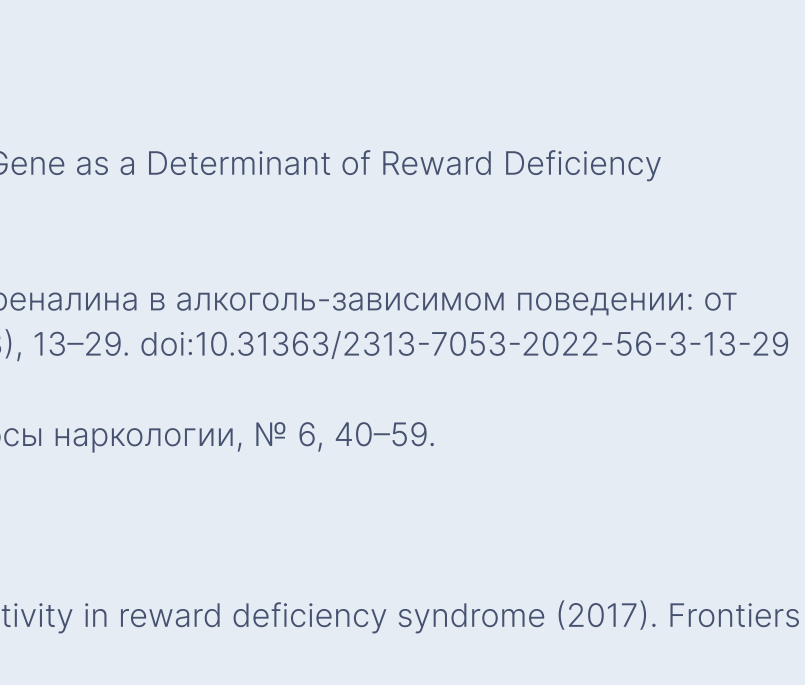
Лечение алкогольной зависимости: почему сила воли здесь ни при чём

Читать



Йога в терапии: снятие абстинентного синдрома, снижение кортизола

Читать



БОС-терапия: тренировка конкретных зон мозга с помощью технологий

Читать

Запишитесь на встречу

Опишите ситуацию в удобном для вас формате.
Первый разговор ни к чему не обязывает, но может стать шагом к переменам.

ЗАПИСАТЬСЯ

8 (925) 183-64-64
Или позвоните нам

дом Шпиговский
центр профилактики зависимостей
8 (925) 183-64-64
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
ЗАПИСАТЬСЯ

Москва и Московская область
Режим работы: пн-пт 09:00-19:00,
сб-вс 09:00-20:00

Info@shpigovsky.ru
почта для заявок

© 2026 Все права защищены.
По вопросам, связанным с обработкой ваших персональных данных, обращайтесь на Info@shpigovsky.ru

Название раздела
Название
Название
Название
Название
Название

Название раздела
Название
Название
Название
Название

Название раздела
Название
Название
Название
Название

Разработка и продвижение: Overseo
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение